Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5165420-70.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: JACQUELINE FAGUNDES IBEIRO

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

JACQUELINE FAGUNDES IBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela contra **BRADESCO SAÚDE S/A**, partes já qualificadas. Narrou que nos dias 17 e 28/06/2024 requereu administrativamente à ré a troca do seu tratamento oncológico, a fim de que fossem fornecidas as medicaçoes Temozolamida (Temodal) e Brevacizumabe (Avastin) para tratar câncer cerebral que lhe acomete, o que lhe foi negado em 19/07/2024. Disse que efetuou pedido de reconsideração conforme Resolução Normativa 465/2021 da ANS, mas mantida a negativa, sob alegação de que o medicamento prescrito não possui registro na Anvisa e não está elencado nas terapias antineoplásicas obrigatórias. Afirmou que houve aprovação pela Anvisa dos medicamentos prescritos (Temozolamida desde 25/07/2011 e Bevacizumabe desde 16/05/2005) e que o laudo médico é categórico quando prescreve o tratamento. Discorreu sobre o risco de agravamento do seu quadro de saúde e direito aplicável à espécie. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o Hospital São Lucas da PUC a fornecer e aplicar as medicações prescritas, quais sejam: Bevacizumabe 250 mg a cada 15 dias, via endovenosa, e Temozolamida 80 mg, diariamente, via oral. Postulou ao final a procedência da ação, a fim de que seja autorizada pela ré a cobertura do tratamento postulado, confirmando a tutela antecipada. Peliteou a gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1).

Foi deferida a medida antecipatória (eventos 7 e 18).

Atacando essa decisão, a ré interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido.

A ré noticiou o cumprimento da liminar e apresentou contestação (eventos 23 e 24). Preliminarmente, impugnou o valor da causa, argumentando que, tratando-se de obrigação de fazer, deveria ser atribuído o de alçada. No mérito, referiu que não se opõe ao fornecimento do medicamento Temodal (Temozolamida 80mg), eis que existente cobertura e pertinência técnica para tal fármaco. Defendeu que, relativamente ao medicamento Avastin, em que pese existente registro junto à ANVISA, inexiste obrigatoriedade de cobertura porque está sendo utilizado de forma experimental (*off label*). Teceu considerações acerca da legislação aplicável. Requereu ao final o acolhimento da preliminar e a improcedência. Anexou documentos.

Sobreveio réplica (evento 35).

Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, as partes quedaram silentes.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato.

Passo a decidir.

A ré apresentou impugnação ao valor da causa, sustentando que por se tratar de ação com objeto econômico inestimável, o valor da causa deveria ser o valor de alçada, e não o valor atribuído pela autora na inicial: R$ 191.543,04.

Nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamento/tratamento, o correto é calcular o valor do fármaco/tratamento pela quantidade de meses que a parte necessitar. Caso não haja tempo definido, como no caso dos autos, o valor deverá corresponder aos doze meses do ano.

Tal forma de cálculo é compatível com a previsão do artigo 292, II e §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que "*na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida"* e que *"o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações"*.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE CUSTEIO. LENVATINIBE (LENVIMA). ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA DEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL CONTRATADO. NÃO ABUSIVO. - Impugnação ao valor dado à causa: O caso em análise trata de pedido de cumprimento de contrato de plano de saúde, consubstanciado no fornecimento do medicamento Lenvatinibe (LENVIMA), com uso diário de 24 mg, por período mínimo de 6 meses. Neste viés, ***o valor da causa deverá ser fixado em consonância com a previsão contida no art. 292, II c/c § 2º, do diploma processual.*** *- Mérito: (...). PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50014396320218210066, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-08-2024. Grifo próprio)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PACIENTE COM METÁSTASE PULMONAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ARTIGO 292, II, §2º, DO CPC. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA E LEGÍVEL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO. - Valor da causa. ***O valor da causa foi devidamente atribuído de acordo com o artigo 292, II, §2º, do CPC, observando o menor orçamento e correspondente a uma prestação anual.*** *- Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento LENVIMA (lenvatinibe). Tratamento de metástase pulmonar. (...). Recurso que vai parcialmente provido, a fim de arbitrar a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, §2º e 6º-A do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAL PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível, Nº 50057869320228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 15-08-2024)*

Assim, correta a atribuição do montante correspondente ao custo anual dos medicamentos vindicados, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia subsiste relativamente ao fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE (nome comercial Avastin), conforme prescrição médica, para tratamento do glioblastoma recidivado.

O relatório médico juntado no evento 1, LAUDO2 bem resume o tratamento seguido desde 2014 e a necessidade do medicamento:

Relatório Médico

Referente paciente Jacqueline Fagundes Iberio

A paciente supra-citada teve diagnóstico inicial de glioma baixo grau de malignidade em 2014, para o qual foi tratada com ressecção cirúrgica. Permaneceu em observação e controle de exames de imagem e, em 2015, foi constatada progressão de doença, sendo indicada nova ressecção cirúrgica, que foi realizada e seguida por radioterapia complementar.

Em 11/2021, foi constatada nova progressão de doença, sendo novamente realizada ressecção cirúrgica, cujo anátomo –patológico revelou Glioblastoma. Nesta ocasião, realizou radioterapia complementar e quimioterapia com Temozolomida, que utilizou até 11/2023, ficando em observação após.

Em junho de 2024, apresentou piora neurológica e necessitou de internação hospitalar devido a crises convulsivas e hipertensão intra-craniana, sendo submetida a nova ressecção cirúrgica.

Necessita iniciar, o mais brevemente possível, tratamento oncológico com as medicações Temozolomida, na dose de 50 mg/m² via oral, uma vez ao dia (dose total= 80 mg/dia) e bevacizumabe, na dose de 5 mg/kg, endo- venoso a cada 14 dias (dose total= 250 mg).

Estas medicações são recomendadas no tratamento do glioblastoma recidivado e necessitam ser iniciadas rapidamente devido ao risco de progressão da doença com evolução para hipertensão intra-craniana e morte.

Portanto, verifica-se que a autora já utilizou todos os procedimentos e medicamentos disponíveis no mercado sem obter sucesso terapêutico, tendo sido indicado o medicamento objeto da presente ação sob pena de risco iminente de evolução da doença e, consequentemente, de grave dano e até mesmo a morte.

A requerida negou cobertura para o fornecimento do aludido medicamento sob a alegação de se tratar de tratamento off-label, ou seja, aquele que, embora ministrado como medicamento liberado e reconhecido, não tem indicação específica para o caso do paciente, sustentando ser lícito de exclusão de cobertura contratual, consoante Resolução Normativa n° 465 da ANS, vigente desde 1º/04/2021.

Conforme decidido pelo e. TJRS por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto nos presentes autos (5241985-30.2024.8.21.7000), apesar de não ser aplicável ao caso em tela os ditames do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ré se trata de entidade de autogestão, a análise das cláusulas contratuais deve ser realizada à luz da função social do contrato, da boa-fé e da interpretação mais favorável ao aderente, nos termos dispostos nos arts. 421, 422 e 423 do Código Civil.

Com efeito, uma vez constatada a necessidade do medicamento em questão solicitado pela médica que atende à autora, haja vista sua grave situação de saúde, já tendo utilizado todo tratamento e medicação disponível no mercado para sua doença, sem apresentar o controle devido, como forma de controlar de forma mais adequada a doença, tenho que não há justificativa para a negativa apresentada.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, I, alínea ‘c’, estabelece como cobertura mínima obrigatória a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

Frise-se que a pretensão da parte autora encontra amparo nas inúmeras decisões jurisprudenciais, onde afastada a possibilidade ao plano de escolher o procedimento médico a ser adotado, cuidando-se de critério estritamente médico. Tendo a operadora assumido a responsabilidade pela cobertura da doença que acomete o consumidor (fato incontroverso), no que tange à escolha do tratamento a ser realizado e o tipo de medicamento a ser utilizado, cabe ao médico fazer a indicação mais apropriada ao seu paciente e não ao plano de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. QUIMIOTERAPIA. FOLFIRINOX. ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. COBERTURA CONTRATUAL. 1. Embora o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS constitua apenas a referência básica para os planos privados, conforme redação expressa do § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, este mesmo artigo de lei, em seu inciso VI, autoriza às operadoras dos planos de saúde a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e medicamentos de uso em home care. 2. Medicamentos prescritos para o tratamento de neoplasia maligna que estão incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadrando-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento inclusive de uso domiciliar. Circunstância que, por si só, revela a abusividade da recusa exarada pela operadora do plano de saúde. Outrossim, o uso off label do medicamento, uma vez prescrito pelo médico assistente, não constitui causa a respaldar a negativa de cobertura. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença de procedência. Honorários recursais arbitrados (art. 85, §11, do CPC). Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50061778720218210036, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 31-07-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CUSTO DO TRATAMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA. O FATO DE A MEDICAÇÃO SER "OFF LABEL", OU SEJA, EMPREGADA PARA USO CUJA INDICAÇÃO NÃO ESTÁ NA BULA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO SEU FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50137736020228210013, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-02-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras. - É indevida a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do procedimento prescrito pelo médico, mesmo sendo ele off label, quando necessário ao tratamento de enfermidade que seja objeto de cobertura pelo contrato. Caso em que devido o procedimento solicitado pela autora, uma vez que constante do Rol da ANS, ainda que para neoplasia diversa. - A negativa ofertada pela ré foi fundamentada no fato de que os procedimentos solicitados estavam em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS e, nesse contexto, a operadora do plano de saúde, em atenção ao contrato, não estava obrigada a custear o tratamento, destacando que o medicamento não encontrava correlação para com o tipo de câncer / neoplasia. Sentença de procedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50006046220228210059, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-10-2023)

Dessa forma, considerando que restou configurada a necessidade do uso do medicamento prescrito pela médica assistente da autora, dada sua grave situação de saúde, tenho que a procedência do pedido é medida que se impõe, confirmando-se a tutela antecipada concedida.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **JACQUELINE FAGUNDES IBEIRO** contra **BRADESCO SAÚDE S/A,** para, confirmando a tutela antecipada concedida, determinar que a requerida autorize a cobertura do tratamento prescrito à autora (Evento 1, RECEIT3), na forma pustulada na inicial, confirmando a tutela antecipada concedida, nos termos da fundamentação acima.

Porque sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da advogada da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da causa, atualizado pelo IPCA, forte no art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA AZEVEDO HAMPE, Juíza de Direito**, em 13/02/2025, às 15:20:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10076657867v12** e o código CRC **375555ab**.